

일차 의료용 근거기반
권고 요약 정보



우울증

QUICK REFERENCE GUIDE



대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

일차 의료용 근거기반 우울증 권고 요약 정보

권고 요약 정보를 뒷받침하는 근거의 세부사항은
아래 사이트를 통해
전체 가이드라인 정보를 확인할 수 있습니다.

임상진료지침 정보센터

www.guideline.or.kr

일차 의료용 근거기반 디지털가이드라인

www.digitalcpg.kr



스마트폰 QR코드
www.digitalcpg.kr

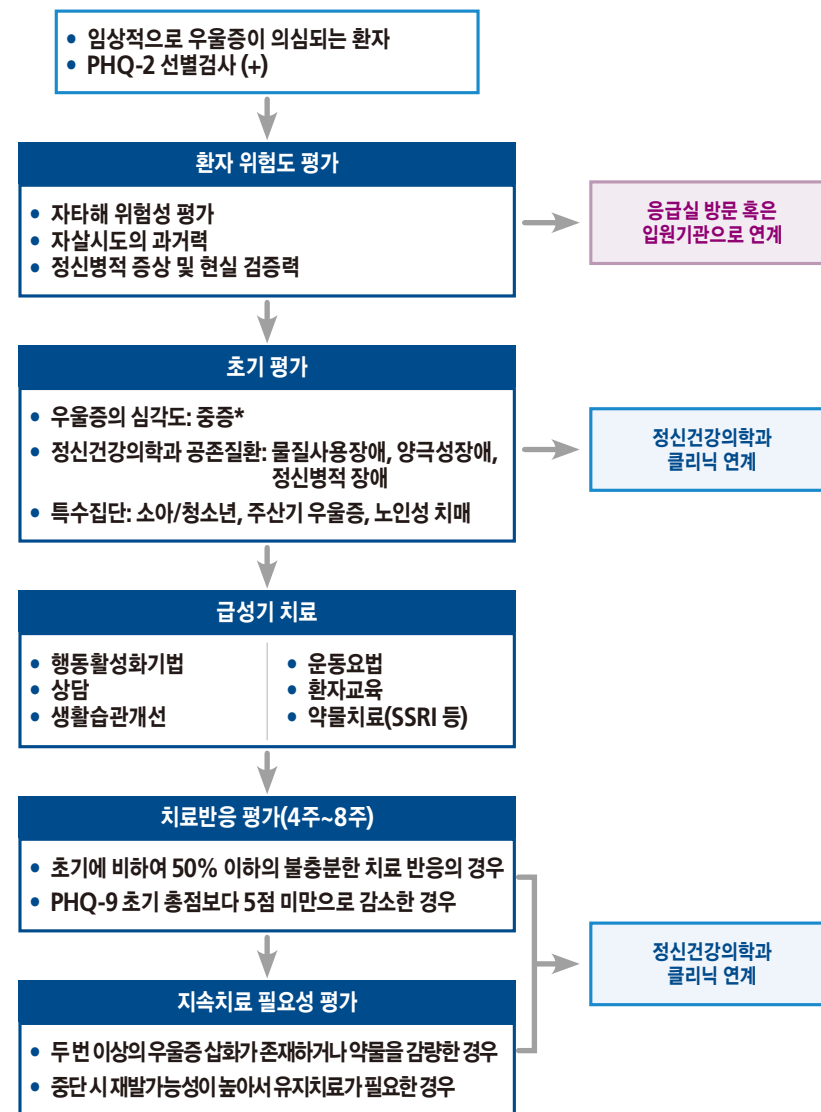


대한의학회
Korean Academy of Medical Sciences



질병관리청

알고리즘 1. 진료의뢰 기준



* 중증: PHQ-9 선별검사 점수가 20점 이상이거나 DSM-5 진단기준 9가지 중 7가지 이상을 만족하고 직업적·사회적 기능저하가 현저한 경우

우울증 선별과 진단

우울증 선별대상

권고

- 현재 우울증 치료를 받지 않는 성인을 대상으로 우울증에 대한 정기적인 선별검사를 권고한다.

우울증 진단방법

권고

- 주요우울장애 진단 시 DSM-5(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)^① 기준에 따른 진단을 권고한다.
- 우울증 환자에서 기능상태, 병력, 과거 치료력, 가족력 등을 포함한 평가를 권고한다.

- ☑ 정기적인 우울증 선별검사를 위해 PHQ-2^②를 이용할 수 있다. (Patient Health Questionnaire, PHQ)
- ☑ PHQ-2에서 양성이거나 만성질환 환자의 경우에는 PHQ-9을 고려한다.
- ☑ 선별검사가 임상적 면담이나 진료를 대체하는 것은 아니다.
- ☑ 현재 병력과 더불어 과거 우울삽화의 횟수나 최근 스트레스요인과 증상의 심각도, 자살경향성, 정신과적 동반질환 등을 함께 평가한다.

① 주요우울장애 DSM-5 진단기준 [부록 14쪽 참고]

② PHQ-2 설문지 [부록 15쪽 참고]

자살평가

- ☑ 자살에 대한 평가는 우울증의 치료 과정에서 반드시 필요하다.
- ☑ 자살시도력이 있는 우울증 환자는 그렇지 않은 환자에 비해 조기발병, 병의 심각도, 장기 이환, 재발, 낮은 치료반응, 낮은 관해율과 밀접한 연관관계가 있다.
- ☑ 자살위험도 평가는 자살위험요인과 현재 자살생각 및 행동의 중증도를 파악해야 한다.
- ☑ 자살위험인자와 더불어 도움을 주는 타인과 같은 보호인자도 고려해야 하며, 자살 위험이 높은 경우 입원치료가 필요하기 때문에 입원 가능성에 대해서 평가한다.
- ☑ 임상가는 이러한 다양한 요인들을 종합적으로 평가하여 자살의 위험도를 판단한다.

환자교육

권고

- 치료를 시작하기 전에 환자와 치료자 간의 치료적 동맹 형성을 고려할 수 있다.
- 치료계획에는 현재의 상태와 치료방법에 따른 위험과 이득을 포함하여 환자교육을 함께하는 것을 권고한다.
- 환자에게 악화의 가능성 및 자살사고가 생길 가능성, 약물치료의 부작용과 이득, 예상치료기간, 약물치료를 중단할 경우 예상되는 부작용, 우울증의 특징 및 경과, 치료, 예후에 대한 교육 시행을 고려할 수 있다.

☑ 환자교육에는 다음과 같은 주제를 포함한다.

- 우울증의 원인, 증상 및 자연경과
- 치료방법 및 최선의 치료를 찾기 위한 과정
- 치료과정 중 발생할 수 있는 것들에 대한 정보
- 증상 및 부작용을 모니터링 하는 방법
- 추적관찰 계획
- 재발의 초기경고 징후
- 치료기간
- 보호자와의 소통

환자교육

☑ 항우울제를 처방할 시에는 치료목적의 달성과 치료순응도를 높이기 위하여 다음과 같은 환자교육이 필요하다.

- 치료효과가 나타나기 이전에 약물의 부작용이 나타날 수 있으며, 이는 대부분 시간이 경과하면 없어진다.
- 대부분의 경우 치료효과가 나타나기 시작한 이후로 6개월-1년 이상의 치료가 필요하다.
- 2주 후부터 증상의 호전이 나타날 수 있으나 완전관해 및 회복에는 더 많은 시간이 필요할 수 있다.
- 증상의 호전이 있다고 해도 약물을 임의로 감량해서는 안 되며, 의사의 지시대로 복용해야 한다. 조기에 항우울제 치료를 중단하는 것은 증상의 재발가능성을 높하게 되며, 재발의 횟수가 증가할수록 치료가 더욱 어려워진다.
- 의사와 상의하지 않고 약물을 중단해서는 안 된다. 약물의 부작용은 복용 용량이나 스케줄의 변경 등으로 간단하게 해결될 수 있다.

☑ 환자 및 가족들에게 다음과 같은 내용의 교육이 이루어져야 한다.

- 우울증은 성격적인 문제가 아니라 의학적인 질병이다.
- 대부분의 경우 치료에 의해 호전이 가능하다.
- 급성기 치료 목표는 완전하게 증상이 없어지는 관해이지만 유지기의 치료 목표는 단순히 증상이 좋아지는 게 아니라 재발방지가 중요하다. 환자 및 가족들은 재발의 초기 징후에 대해서 잘 알고 있어야 하며, 이러한 징후가 나타날 경우 즉시 의료진의 도움을 구해야 한다.

주요 약물

- ☑ 우울증 치료에 사용하는 주요 항우울제는 SSRI, SNRI, mirtazapine, agomelatine, bupropion, vortioxetine 등이 있다.

☑ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI)

- escitalopram, fluoxetine, paroxetine, sertraline 등이 있다.
- 우울증상의 치료에 효과적이며, TCA에 비해 항콜린성 부작용, 진정 효과 등의 부작용이 적다.

☑ Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI)

- desvenlafaxine, duloxetine, milnacipran, venlafaxine 등이 있다.
- 우울증상의 치료에 효과적이며, 특히 통증 및 신체 증상 감소에 효과가 있다.

☑ Mirtazapine

- 우울증상의 치료에 효과적이며, 특히 불면, 식욕 및 체중 감소, 불안 증상 감소에 효과가 있다.

☑ Agomelatine

- 우울증상의 치료에 효과적이며, 수면시간 및 질의 향상에 효과가 있다.

☑ Bupropion

- 우울증상의 치료에 효과적이며, 특히 정신운동지체, 피로감, 집중력 저하를 개선하는 효과가 있다.

☑ Vortioxetine

- 우울증상의 치료에 효과적이며, 특히 인지기능 보존 및 향상에 효과가 있다.

☑ Tri-or tetra-cyclic antidepressants(이하 TCA)

- 우울증상의 치료에 효과가 있으나, 심각한 약물 부작용으로 인해 낮은 선호도를 가진다.

우울증 약물치료

권고

- 주요우울삽화를 갖는 환자에게 약물치료를 권고한다.
- 약물치료 뿐만 아니라 정신사회적 중재법(정신치료, 인지행동치료, 대인관계치료, 운동 등)과 병합하여 포괄적인 치료계획을 세울 것을 권고한다.
- 항우울제는 임상양상, 공존질환, 이전의 약물치료 병력, 부작용, 약물상호작용, 환자의 기호 등을 종합하여 선택할 것을 권고한다.
- 1차 치료 항우울제는 SSRI (escitalopram, sertraline, fluoxetine, paroxetine 등), SNRI (duloxetine, milnacipran, venlafaxine, desvenlafaxine 등), mirtazapine, agomelatine, bupropion, vortioxetine에서 선택할 것을 권고한다.
- 급성기 치료에서 관해에 이르면 재발방지를 위해 유지치료 시행을 고려할 수 있다.

- 가임기의 여성인 경우에는 치료 중간에도 임신계획에 대한 평가를 반드시 해야 한다.
- 자살 등의 응급상황이 예상되면 대처방법(응급실 방문 등)을 설명하거나 비상연락처를 공유하는 것이 유용하다.
- 2차 항우울제로는 TCA (amitriptyline, imipramine, nortriptyline 등), modobemide, tianeptine 등에서 선택할 것을 고려한다.
- 비정형 항정신병약물(quetiapine, aripiprazole)은 초기 약물치료에 반응이 부족한 경우에 추가 약물로 권고한다.
- 자신이나 타인을 해칠 위험성이 높은 급박한 위험상황에서는 전기경련요법(Electroconvulsive Therapy, ECT) 적용을 고려한다.
- 임신부처럼 약물치료를 못할 경우에는 경두개자극법(Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) 등의 비약물적 생물학적 치료를 고려한다.

추적관찰

- ✓ 약물복용 후 증상의 호전은 최소 2주 이상의 기간이 필요하며, 적절한 치료반응과 관해를 위해서는 좀 더 긴 기간이 필요하다.
- ✓ 치료를 시작하거나 변경 후 관해가 될 때까지는 최소 한 달 이내 간격으로 모니터링을 권하며, 증상을 포함한 약물 및 정신치료의 순응도, 부작용 등에 대한 평가가 이루어져야 한다.
- ✓ 적절한 치료반응을 보인 경우 초기 급성기 치료 후 최소 6-12개월간의 약물치료를 유지해야 한다.
- ✓ 항우울제를 복용 후 부작용(adverse effect)은 시간이 지나면서 호전되기도 하지만, 추적관찰 중에 부작용의 호전이 없으면 치료 득실에 따라 약물교체나 감량 후 중단을 고려한다.



진료의뢰 기준

- 중증 우울증상을 보이는 환자와 중등도의 우울증상이나 복합적인 증상, 정신병적 증상을 보이는 우울증 환자의 경우 정신건강전문가들에 의한 팀 접근 치료를 위해 정신건강의학과 전문의에게 의뢰하는 것을 고려한다.
- 적정 용량과 기간 동안 시행한 한두 가지 약물치료에 반응하지 않는 경우, 종합적인 평가를 통해 통합적인 우울증 치료계획을 세울 수 있도록 정신건강의학과 전문의에게 의뢰하는 것을 고려한다.
- 정신건강의학과 전문의에게 의뢰된 우울증 환자의 종합적 평가에는 아래와 같은 사항을 포함할 것을 고려한다.
 - 증상특성 평가, 자살위험성 평가, 이전 치료 과거력의 적절성 평가
 - 재발성 또는 만성 우울증의 경우 연관된 심리사회적 스트레스 요인, 인격요인, 중요한 대인관계 어려움 등의 평가
 - 알코올 또는 약물남용, 인격장애 등의 공존 정신질환에 대한 평가

권고

- 아래와 같은 특성을 보이는 우울증 환자의 경우 종합병원 정신건강의학과 전문의에게 의뢰할 것을 고려한다.
 - 동반된 내과적 질환으로 인하여 약물상호작용 등을 고려한 약물치료가 필요한 경우
 - 자살위험성이 관찰되는 경우
 - 전기충격요법 등 특수치료가 필요한 경우
 - 노인 우울증에서 전신상태가 쇠약한 경우
 - 신체질환으로 인한 다학제 치료가 필요한 경우
 - 임신 혹은 출산 후 중등도 이상의 우울증이 발생한 경우
 - 중증정신질환의 과거력이 있는 임신 중 또는 산후 우울증이 있는 여성
 - 중등도 이상의 우울증으로 통합적인 심리사회적 평가와 개입이 필요한 아동 및 청소년
- 우울증 환자를 진료할 때, 자살위험성이 관찰되거나 타인을 위협하게 할 수 있는 상황(예: 산후우울증 환자의 영아에 대한 위해가능성 등)이 관찰될 경우, 정신병적 증상(예: 환각, 망상 등)이 동반된 경우 등에는 정신건강의학과 전문의에게 의뢰해야 한다.
- 양극성장애(조울증)와의 감별진단을 포함해 공존 정신질환에 대한 감별진단과 치료가 필요할 경우에도 정신건강의학과 전문의에게 의뢰해야 한다.

주요우울장애 DSM-5 진단기준

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

	다음의 증상 가운데 5가지 이상의 증상이 2주 연속으로 진행되며, 증상 중에 적어도 하나는 (1) 우울기분이거나 (2) 흥미나 즐거움의 상실이어야 한다.
기준 A	1 하루 중 대부분 그리고 거의 매일 지속되는 우울 기분 2 거의 매일, 하루 중 대부분, 거의 모든 일상 활동에 대해 흥미나 즐거움이 뚜렷이 저하됨 3 체중조절을 하지 않은 상태에서 의미 있는 체중의 감소나 증가 4 거의 매일 나타나는 불면이나 과다수면 5 거의 매일 나타나는 정신운동 초조나 지연 6 거의 매일 나타나는 피로나 활력의 상실 7 거의 매일 무가치감 또는 과도하거나 부적절한 죄책감 8 거의 매일 나타나는 사고력이나 집중력의 감소, 우유부단함 9 반복적인 죽음에 대한 생각, 구체적인 계획 없이 반복되는 자살사고, 또는 자살시도나 자살수행에 대한 구체적인 계획
기준 B	증상이 사회적, 직업적 또는 다른 중요한 기능영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 손상을 초래한다.
기준 C	삽화가 물질의 생리적 효과나 다른 의학적 상태로 인한 것이 아니다.

[출처: BPAC New Zealand. Best practice adult depression. 2009.]

PHQ-2 설문지

Patient Health Questionnaire

문항	전혀 방해 받지 않았다	며칠 동안 방해 받았다	7일 이상 방해 받았다	거의 매일 방해 받았다
1) 지난 한달 동안 당신은 자주 기분이 처지거나 우울하거나 희망이 없다는 느낌으로 고민하고 있습니까?	0	1	2	3
2) 지난 한달 동안 당신은 자주 일상적인 활동에 흥미나 즐거움의 감소 때문에 고민하고 있습니까?	0	1	2	3

참고. PHQ-2 점수 해석

PHQ-2 점수	주요우울장애 확률(%)	기타 우울장애 확률(%)
1	15.4	36.9
2	21.1	48.3
3	38.4	75.0
4	45.5	81.2
5	56.4	84.6
6	78.6	92.9

[출처: VA/DoD. Clinical practice guideline for the management of major depressive disorder. 2016.]



약물정보 ① 항우울제 선택

항우울제 권고 요약표

항우울증 약	기전	용량
제1차 약제		
아고멜라틴(agomelatine)	MT ₁ and MT ₂ agonist; 5-HT ₂ antagonist	25-50mg
부프로피온(bupropion)	NDRI	150-300mg
시탈로프라ם(citalopram)	SSRI	20-40mg
데스벤라팍신(desvenlafaxine)	SNRI	50-100mg
듀록세틴(duloxetine)	SNRI	60mg
에스시탈로프라ם(escitalopram)	SSRI	10-20mg
플루옥세틴(floxetine)	SSRI	20-60mg
플루복사민(flvoxamine)	SSRI	100-300mg
밀나시프란(milnacipran)	SNRI	100mg
멀타자핀(mirtazapine)	α ₂ -Adrenergic agonist; 5-HT ₂ antagonist	15-45mg
파록세틴(paroxetine)	SSRI	20-50mg
설트랄린(sertraline)	SSRI	50-200mg
벤라팍신(venlafaxine)	SNRI	75-225mg
보티오섹틴(vortioxetine)	Serotonin reuptake inhibitor; 5-HT _{1A} agonist; 5-HT _{1B} partial agonist; 5-HT _{1D} , 5-HT _{3A} , and 5-HT ₇ antagonist	10-20mg
제2차 약제		
아미트립틸린(amitriptyline)	TCA	30-300mg
이미프라민(imipramine)	TCA	25-200mg
노르트리틸린(nortriptyline)	TCA	10-150mg
트라조돈(trazodone)	Serotonin reuptake inhibitor; 5-HT ₂ antagonist	150-300mg
모노클로베미드(monoclobemide)	Reversible inhibitor of MAO-A	300-600mg

[출처: Kennedy SH, Lam RW, McIntyre RS, et al. CANMAT 2016 clinical guideline for the management of adults with major depressive disorder: section 3. pharmacological treatment. Can J Psychiatry 2016;61(9):540-560.]

약물정보 ① 항우울제 선택

부작용을 고려한 항우울제 선택

	1차 선택약물	2차 선택약물	3차 선택약물
성기능 장애	bupropion	mirtazapine	tianeptine
졸리움, 진정작용	bupropion	fluoxetine	sertraline
체중증가	fluoxetine	bupropion	tianeptine
수면장애(불면)	mirtazapine	paroxetine	TCA
소화기장애(오심/구토)	mirtazapine	tianeptine	bupropion
항콜린성 부작용	escitalopram	sertraline	bupropion

[출처: 대한우울조울병학회, 대한정신약물학회. 한국형 우울장애 약물치료 지침서. 2017.]

안정성을 고려한 항우울제 선택

	1차 선택약물	2차 선택약물	3차 선택약물
고혈압	escitalopram	sertraline	tianeptine
저혈압	escitalopram	sertraline	tianeptine/ bupropion
세로토닌증후군	bupropion	tianeptine	agomelatine
뇌전증	escitalopram	sertraline	tianeptine
심장 부정맥	escitalopram	sertraline	tianeptine
자살사고 증가	mirtazapine	bupropion	tianeptine

[출처: 대한우울조울병학회, 대한정신약물학회. 한국형 우울장애 약물치료 지침서. 2017.]

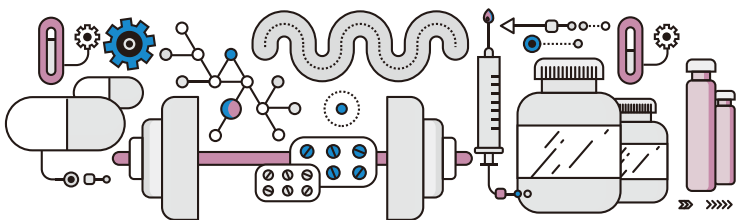
공존 신체질환을 고려한 항우울제 선택

	1차 선택약물	2차 선택약물	3차 선택약물
당뇨병	escitalopram	sertraline	-
갑상선질환	escitalopram	sertraline	fluoxetine/ bupropion
간질환	escitalopram	sertraline	tianeptine
신장질환	escitalopram	sertraline	tianeptine

[출처: 대한우울조울병학회, 대한정신약물학회. 한국형 우울장애 약물치료 지침서. 2017.]

약물정보 ② 주의가 필요한 약제

- ✓ 우울증 환자들 중 다수는 우울증 이외의 정신과적, 내과적 질환을 함께 가지고 있기 때문에 다른 약을 함께 복용하는 경우가 많다.
- ✓ 많은 수의 항우울제는 특히 간에서 발생하는 CYP450 효소대사를 거치는 약물들과 임상적으로 유의미한 약물상호작용을 가진다.
- ✓ 항우울제와 다른 약 사이의 약물상호작용으로 인하여 약물의 효능이 떨어지거나 부작용이 생길 수 있다.
- ✓ 약물역동학적인 상호작용 때문은 아니더라도 세로토닌 약물과 MAO 억제제를 동시에 사용하면 세로토닌 증후군 혹은 고혈압위기가 생길 수 있는 위험이 있다.



약물정보 ② 주의가 필요한 약제

항우울제 부작용

항우울제	증상	불안 초조	소화 기능	불면	진정 작용	성기능 장애	체중 증가
시탈로프라ם(citalopram)		+	++	++	++	+++	+
플루옥세틴(fluoxetine)		+	++	++	++	+++	+
파록세틴(paroxetine)		+	++	++	++	+++	+
벤라팍신(venlafaxine)		++	+++	++	++	+++	+

부작용의 빈도: + (> 2%) = 거의 없다 / ++ (> 10%) = 종종 나타남 / +++ (> 30%) = 자주 나타남

[출처: BPAC New Zealand. Best practice adult depression. 2009.]

세로토닌 증후군 특성

임상적 특징	유발요인
• 경련성 복통 • 불안초조, 설사, 간대성근경련, 떨림, 혼수, 빈맥, 저혈압, 지남력상실, 발한, 고열	• 과용량 • SSRI+MAOI 혹은 SSRI+serotonergic TCA 같은 약들의 상호작용 • 특이체질 반응

[출처: BPAC New Zealand. Best practice adult depression. 2009.]

세로토닌 증후군 가능성이 있는 약물들

분류	약물
항우울증약	TCA, MAOIs, SSRI, mirtazapine, venlafaxine, St, John's Wort
마약성진통제	tramadol, pethidine, dextromethorphan
자극제	amphetamine, sibutramine
5HT1 agonist	sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan
기타	LSC, cocaine, ecstasy, buspirone, lithium, selegiline, tryptophan, linezolid

[출처: BPAC New Zealand. Best practice adult depression. 2009.]

우울증 환자 관리 체크리스트

첫 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
위험요인 확인	- 자타해 위험성 평가 - 자살시도의 과거력 - 정신병적 증상 및 현실 검증력
우울증 진단	- DSM-5 우울증 진단기준을 만족하는 경우 - PHQ-2 선별검사 상 양성인 경우
중증도 확인	- DSM-5 진단기준 9가지 중 - 경증: 4가지를 만족하는 경우 - 중등증: 5~6가지를 만족하는 경우 - 중증: 7가지 이상을 만족하는 경우 - PHQ-9 선별검사 점수 - 경증: 10~14점 - 중등증: 15~19점 - 중증: 20점 이상 - 사회적·직업적 기능 평가
자가관리 권고	- 생활습관개선 - 운동요법 - 중강도 수준의 신체활동(예비심박수의 70-80%에 해당하는 강도로 주 3회 이상, 30~40분 동안 운동)을 유지 (예. 가벼운 숨참을 느낄 정도의 산책)

매 방문 시

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	- 증상: 기분, 의욕, 체중, 수면, 정신운동증상, 피로나 활력, 죄책감, 집중력, 자살사고 - PHQ-9 자가보고, 초진 시와 비교 4주 후 약물치료 반응 평가 및 약물 부작용 모니터링
자가관리 확인 및 권고	- 생활습관개선 - 운동

우울증 환자 관리 체크리스트

매년

항목	기준/목표/권고사항
모니터링 및 평가	- DSM-5 진단기준 9가지 중 - 경증: 4가지를 만족하는 경우 - 중등증: 5~6가지를 만족하는 경우 - 중증: 7가지 이상을 만족하는 경우 - PHQ-9 선별검사 점수 - 경증: 10~14점 - 중등증: 15~19점 - 중증: 20점 이상 - 사회적·직업적 기능 평가
자가관리 확인 및 권고	- 생활습관개선 - 운동

진료의뢰

항목	기준/목표/권고사항
진료의뢰 기준	- 중증 우울증 - 물질사용장애, 양극성장애, 정신병적 장애 등 정신건강의학과 공존질환이 존재하는 경우 - 소아/청소년, 주산기 우울증, 노인성 치매 등 특수집단에 해당하는 경우

「일차 의료용 근거기반 우울증 권고 요약 정보」는 질병관리청 만성질환예방과의 「일차 의료용 만성질환 임상진료지침 정보센터 운영 지원」 사업의 일환으로 국민건강증진기금 민간경상보조사업비를 지원받아 제작되었음.

우울증

QUICK REFERENCE GUIDE

일차 의료용 우울증 가이드라인 개발 참여 학회

대한신경정신의학회,
대한개원의협의회(대한정신건강의학과약사회), 대한우울조울병학회,
대한정신약물학회, 대한가정의학회